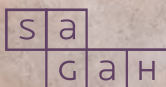


FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E SAÚDE

Simone Machado Kühn de Oliveira



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Conceituação e contextualização em saúde

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Reconhecer os conceitos básicos de saúde assistencial.
- Identificar a complexidade dos serviços em saúde.
- Demonstrar a expectativa do cliente em relação aos serviços da saúde.

Introdução

Saúde não é apenas ausência de doenças. Trata-se de um completo estado de bem-estar nos aspectos físico, mental e social dos indivíduos.

Nesse sentido, é fundamental o entendimento da amplitude desse conceito para a compreensão do funcionamento do sistema de saúde.

Neste capítulo, você vai estudar os conceitos básicos de saúde assistencial, bem como a complexidade dos serviços de saúde oferecidos na atualidade. Além disso, conhecerá as expectativas dos clientes em relação aos serviços de saúde.

Conceitos básicos de saúde assistencial

Para o funcionamento dos serviços de saúde, faz-se necessária a implementação de estrutura adequada, além de planejamento, organização, gestão e financiamento suficientes para manter o sistema. São muitos os fatores envolvidos na construção de um sistema de saúde que contemple todas as necessidades da população de um país tão grande como o Brasil.

O modelo assistencial configura-se na forma em que as ações de saúde são organizadas em um determinado local. Esse tipo de organização abrange tanto os aspectos tecnológicos quanto os assistenciais. Trata-se do modo como são empregados os recursos físicos, tecnológicos e humanos, assim como a articulação entre esses recursos, para que se possam resolver as demandas

de saúde de uma população. Nesse sentido, contempla ações relacionadas ao mapeamento de necessidades, planejamento e distribuição de recursos, monitoramento do funcionamento das ações implementadas e avaliação contínua do funcionamento do sistema de saúde em cada região.

No Brasil, ao longo dos anos, foram sendo desenvolvidos diferentes modelos de organização da assistência à saúde. Compreender a história da evolução dos sistemas é fundamental para entender a complexidade do funcionamento do sistema único de saúde.

A atenção à saúde, no Brasil, sofreu alterações diretamente ligadas ao momento político e social de cada época. No período imperial, a preocupação das autoridades era restrita ao saneamento dos portos, na medida em que influenciavam o comércio. Nas cidades, as ações eram direcionadas ao controle de endemias e epidemias. Os hospitais eram militares. A assistência privada era restrita às pessoas de alto poder aquisitivo. As entidades filantrópicas eram construídas e mantidas pelas Santas Casas de Misericórdia (PAIM, 2003) (Figura 1).



Figura 1. Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro.

Fonte: Ferrez (1895).

Nos primórdios do século XX, instituiu-se um modelo sanitarista, que acarretou um aumento nas campanhas sanitárias. Muitas ações e intervenções nessa época foram realizadas de maneira autoritária. Ações como a vacinação compulsória imposta pelo governo culminaram com o movimento que ficou conhecido como A Revolta da Vacina. Esse período, conhecido também como Sanitarismo Campanhista, teve como característica a assistência médico-hospitalar, oferecida pelo Estado, direcionadas a uma parte específica da população, levando-se em conta a incidência de doenças infecciosas que poderiam atingir a sociedade em geral.

Em meados de 1920, com o aumento da industrialização e o crescimento do número de trabalhadores, iniciaram-se protestos no sentido de que fossem criadas e estabelecidas políticas públicas que garantissem a assistência em saúde (PAIM, 2003).

Na década de 1930, houve o fortalecimento das políticas públicas com a implementação de postos de saúde, além do desenvolvimento de programas que tinham como objetivo o combate ou controle de fatores de risco de doenças. Iniciaram-se programas de pré-natal e de puericultura, e a vacinação foi incentivada.

Entretanto, os programas de saúde desenvolvidos não levavam em conta os fatores ambientais e sociais ou o histórico de saúde do indivíduo. As estratégias de combate às doenças eram formuladas a partir de dados epidemiológicos ou do conhecimento de biologia tradicional.

O modelo de assistência médica direcionado para o combate à doença em sua perspectiva biológica e individualista concentrou força na atenção hospitalar, na especialização médica e no aumento do uso de tecnologias, denominado modelo neoliberal-capitalista, priorizando a fragmentação do cuidado, em detrimento dos fatores sociais que influenciava a saúde das pessoas.

Nesse sentido, o modelo vigente mostrou-se incapaz de resolver as demandas de saúde da população, pois tinha como objetivo somente curar doenças, não trabalhava a promoção da saúde e a prevenção de doenças.

Tiveram início vários programas de saúde, tendo como objetivo incentivar a assistência ambulatorial, além de realização de investimentos em hospitais públicos. Nos anos seguintes os investimentos na atenção ambulatorial aumentaram (PAIM, 2003).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitua saúde como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades”. Nesse sentido, a saúde constitui-se em direito social, intrínseco à cidadania, devendo ser assegurada a todos, sem nenhum tipo de discriminação ou distinção (SEGRE; FERRAZ, 1997).

No Brasil, o direito à saúde é garantido na Constituição Federal, como direito de todos e dever do estado. A Carta Magna salienta, ainda, em seu artigo 5º, que todos são iguais perante a lei. Dessa forma, todos os brasileiros devem ter acesso a ações de promoção de saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação, independente de raça, classe social, sexo, etc. (BRASIL, 1988).

A amplitude do conceito de saúde da OMS remete à reflexão de que não basta não estar doente para ter saúde, é preciso ter qualidade de vida (GIESEL; TRENTIN, 2017). Nesse sentido, para que o indivíduo seja considerado saudável, ele precisa ter qualidade de vida, com meios que lhe proporcionem sua saúde física, mental e social, como:

- saneamento básico;
- água potável;
- coleta de lixo;
- alimentação adequada;
- acesso à educação;
- habitação;
- emprego;
- lazer.

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) veio de encontro às prerrogativas constitucionais. A assistência em saúde passou a ser oferecida de forma gratuita à população, podendo, ainda, ser ofertada pela iniciativa privada, sendo o SUS um sistema nacional e público. Nesse contexto, os serviços de atenção primária e o atendimento de urgências são oferecidos pelo SUS, enquanto que os serviços de maior complexidade são comprados de entidades privadas.

O Programa Saúde da Família (PSF), instituído como base desse sistema, tem como objetivo ampliar a assistência básica de saúde, fomentando práticas humanizadas que viabilizem o atendimento integral da população. Além disso, foram implementadas políticas públicas voltadas para a promoção de saúde, redução de riscos e prevenção de doenças.

O atendimento das diretrizes e princípios do SUS constitui-se no maior desafio da atualidade, na medida em que ainda existem muitos entraves na garantia da acessibilidade, bem como ineficiência e inadequação dos serviços oferecidos à demanda encontrada. Além disso, uma das grandes dificuldades é oferecer a integralidade do cuidado, na medida em que, na maioria das vezes, as ações são voltadas para o tratamento de um problema pontual, sem que se leve em conta o indivíduo como um todo (MOSSER; BEGUN, 2016).



Fique atento

A Constituição Federal do Brasil, de 1988, assegura, em seus artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (BRASIL, 1988, documento on-line).

Complexidade dos serviços de saúde

No Brasil, os serviços de saúde são regulados pela Lei nº. 8080/90, que estabelece como devem funcionar as ações e os serviços de saúde em todo o território brasileiro. De acordo com a legislação supracitada, o Estado tem o dever de formular e executar “[...] políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1990, documento on-line).

A Lei nº. 8080/90 define ainda os determinantes e condicionantes em saúde, citando saneamento básico, alimentação, educação, moradia, meio ambiente, emprego, transporte e lazer como fatores que devem ser amparados na adoção de políticas públicas voltadas à promoção de saúde e à prevenção e ao tratamento de doenças.

Nesse contexto, expressa o funcionamento do SUS, definindo-o como: “O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público” (BRASIL, 1990, documento on-line).

Para garantir a integralidade na assistência de saúde caracterizada na Lei nº. 8080/90, a assistência em saúde foi dividida em diferentes níveis de complexidade, oferecendo desde o atendimento inicial (atenção básica), até serviços de alta complexidade.

Nesse sentido, instituíram-se os três níveis de atenção que compõem a rede assistencial do SUS.

Atenção primária

A porta de entrada do sistema de saúde é a atenção primária ou, como é chamada no Brasil, a atenção básica. A Portaria do Ministério da Saúde nº. 2.436/2017 regula a atenção básica, estabelecendo as normas e diretrizes para o seu funcionamento (BRASIL, 2017).

A atenção básica configura-se por um conjunto de ações, no campo individual ou coletivo, que compreendem a promoção da saúde, a prevenção de doenças e agravos, o diagnóstico, o tratamento adequado, a reabilitação do doente e a manutenção da saúde.

Através de práticas assistenciais, gerenciais e sanitárias, são oferecidas ações em saúde destinadas a populações de territórios delimitados. O PSF e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS) são as estratégias fundamentais para o desenvolvimento dessas ações.

O PSF utiliza-se de tecnologias de alta complexidade e baixa densidade, buscando, assim, resolver as demandas de saúde mais frequentes em seu território adstrito. A tecnologia de baixa densidade compreende procedimentos simples e de baixo custo (BRASIL, 2017).

Dessa forma, a atenção básica configura-se no primeiro nível de atenção aos usuários, devendo ter seu acesso facilitado, atendendo-se aos princípios do sistema único de saúde. Nesse sentido, a unidade básica de saúde (com equipe de estratégia da saúde da família ou não) deve possuir uma equipe multiprofissional de saúde, capaz de atender às necessidades da população local, além de possuir a infraestrutura necessária para o atendimento da população adstrita ao seu território de abrangência, bem como os equipamentos e materiais necessários ao atendimento efetivo e eficaz (BRASIL, 2017).

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) tem como estratégia fundamental a Saúde da Família, visando a consolidação e a expansão da atenção básica à população brasileira (BRASIL, 2012). Desse modo, define as equipes de saúde da família (ESF) como capazes de qualificar, reorganizar e expandir a atenção básica nos moldes do SUS. Para isso, estabelece que cada equipe de saúde da família deve ter, no mínimo: um médico, de preferência com especialização em medicina de família e comunidade, um enfermeiro, de preferência especialista em saúde da família, um auxiliar e/ou técnico de enfermagem e um Agente Comunitário de Saúde (ACS). A PNAB estabelece, ainda, que essa equipe poderá ser complementada com o Agente de Combate

a Endemias (ACE), o odontologista, de preferência com especialização em saúde da família, e o auxiliar ou técnico em saúde bucal (BRASIL, 2017).

As equipes devem ser capazes de conhecer a população adstrita, realizando o levantamento de indicadores que permitam o planejamento estratégico de ações e intervenções em saúde que contemplem as necessidades apontadas nos relatórios. Para isso, o trabalho da equipe multiprofissional de saúde e dos agentes comunitários de saúde é fundamental.

A Unidade Básica de Saúde (UBS) deve disponibilizar consultas com médico generalista e algumas especialidades (sempre que possível), acolhimento e consultas de enfermagem, consultas de odontologia e a realização de pequenos procedimentos médicos, de enfermagem e odontológicos, além de vacinação, respeitadas as condições que sua infraestrutura oferecer.

Em casos onde se faz necessário um atendimento de maior complexidade, superando os limites ofertados pela atenção básica, o paciente deve ser encaminhado a serviços de maior complexidade através dos fluxos de referência e contra-referência, garantindo-se, assim a assistência de serviços especializados e/ou atendimento hospitalar na atenção secundária ou terciária.

Atenção secundária

A atenção secundária configura-se nos serviços de média complexidade, tais como consultas em especialidades médicas clínicas e cirúrgicas, apoio diagnóstico (exames de imagem, biópsias, etc.) e terapêutico. Além disso, contempla o atendimento de urgência e emergência oferecido em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou hospitais gerais. Procedimentos e cirurgias também podem estar inseridos na atenção secundária.

Nesse contexto, o Ministério da Saúde define a atenção secundária como o atendimento formado por serviços que têm como objetivo contemplar as principais demandas, doenças e agravos de saúde dos usuários, tendo, para isso, profissionais especializados e recursos tecnológicos adequados ao apoio diagnóstico e tratamento.

Nesse sentido, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), relaciona os grupos que integram o atendimento de média complexidade no sistema de saúde, a saber:

- cirurgias ambulatoriais especializadas;
- procedimentos traumatológico-ortopédicos;
- ações especializadas em odontologia;
- patologia clínica;

- anatomopatologia e citopatologia;
- radiodiagnóstico;
- exames ultrassonográficos;
- diagnose;
- fisioterapia;
- terapias especializadas;
- próteses e órteses;
- anestesia (BRASIL, 2009).

Pode-se perceber, que os serviços oferecidos pela atenção secundária ou de média complexidade são serviços ambulatoriais especializados ou hospitalares que demandam tecnologias de densidade tecnológica intermediária, ou seja, não se encaixam em atenção básica, tampouco em atenção terciária.

Atenção terciária

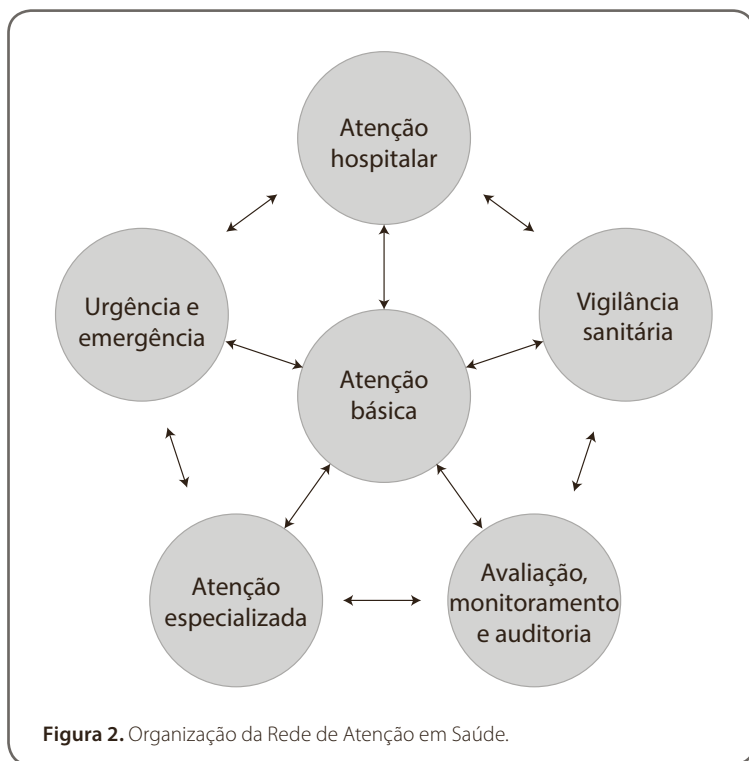
A atenção terciária é constituída pelos serviços de alta complexidade, ou seja, terapias e procedimentos de alta complexidade e tecnologia de densidade tecnológica alta, que exigem um alto grau de especialização. Nesse contexto, incluem-se procedimentos de custo muito elevado.

Podem-se citar como alguns exemplos de serviços de alta complexidade:

- procedimentos e cirurgias em cardiologia, oftalmologia e oncologia;
- neurocirurgia;
- partos de alto risco;
- traumatologia e ortopedia;
- hemodiálise;
- cirurgias reparadoras;
- reprodução assistida e genética clínica;
- cirurgia bariátrica;
- quimioterapia e radioterapia;
- hemoterapia;
- ressonância magnética;
- medicina nuclear e outros.

Verifica-se que a atenção terciária inclui serviços que são destinados apenas à parcela da população que deles necessita, ou seja, a oferta é restrita à necessidade. Desse modo, os serviços são regionalizados de acordo com os indicadores epidemiológicos de cada região.

A rede de atenção à saúde foi organizada de modo a oferecer aos usuários a atenção integral em saúde, preconizada na Constituição Federal e na Lei nº. 8080/90. Pretende-se, com essa organização, proporcionar os recursos necessários aos atendimentos em tempo hábil, em lugar adequado, com um custo aceitável e com a qualidade que possa garantir a eficiência e a eficácia do cuidado (Figura 2).



O SUS é um sistema público (que, conforme a Lei nº. 8080/90, pode ser complementado pela iniciativa privada) e que deve oferecer acesso universal aos cidadãos, garantindo uma assistência integral em todas as esferas do cuidado.

A organização da rede de atenção deve ser feita de modo a garantir a eficiência e a qualidade nos serviços oferecidos à população, otimizando ações, viabilizando a utilização racional dos recursos, a acessibilidade, a integração horizontal e vertical entre os serviços que integram a rede, o planejamento de substituições, a divisão em territórios sanitários e a articulação entre os níveis de atenção (ver Figura 2).

Nesse sentido, as redes de atenção devem ser organizadas em arranjos produtivos, constituídos com a combinação entre a concentração de alguns serviços e a descentralização de outros. Assim, serviços de menor complexidade tecnológica podem ser mais distribuídos, enquanto que os de maior complexidade devem ficar mais centralizados.



Saiba mais

A revolta da vacina foi uma rebelião popular que ocorreu no período de 10 a 16 de novembro de 1904, no Rio de Janeiro. O conflito foi motivado por uma lei que tornou a vacinação contra a varíola obrigatória. Além disso, as campanhas sanitárias coordenadas pelo médico Oswaldo Cruz e as reformas urbanas executadas pelo prefeito Pereira Passos também motivaram o conflito.

A cidade do Rio de Janeiro apresentava sérios problemas relacionados à saúde pública, com epidemias de varíola, peste bubônica e febre amarela. A infraestrutura da cidade já não se ajustava à condição de capital. Com o objetivo de modernizar a cidade e controlar as doenças, o presidente Rodrigues Alves determinou reformas que alteraram a configuração geográfica da cidade, modificando a rotina dos habitantes.

Para atingir seu objetivo, determinou o alargamento de ruas, a demolição de cortiços e a retirada dos moradores pobres. A campanha de saneamento, liderada por Oswaldo Cruz, tinha como objetivo erradicar a varíola, a peste bubônica e a febre amarela. Para isso, publicou um projeto de lei que tornava obrigatória a vacinação, exigindo documentação de comprovação para a entrada em escolas, empregos, realização de viagens, hospedagens e, até mesmo, casamento, além de multas para quem oferecesse resistência à vacinação.

A população revoltou-se e iniciou o protesto, que levou a muitos conflitos e uma tentativa de golpe de estado, que fracassou. Em 16 de novembro, o presidente decretou o estado de sítio e o cancelamento da obrigatoriedade da vacina. O conflito deixou 30 mortos e 110 pessoas ficaram feridas (FIOCRUZ, 2005) (Figura 3).



Figura 3. Revolta da vacina.

Fonte: História do Brasil (2019).

Expectativa do cliente com os serviços da saúde

O mundo vive, na atualidade, o fenômeno das mudanças tecnológicas cada vez mais aceleradas, exigindo constante atualização e adaptação das pessoas e das organizações. Os serviços de saúde, principalmente as instituições hospitalares, configuram-se em grandes organizações empresariais que precisam estar em consonância com a evolução tecnológica da assistência médico-hospitalar que oferecem aos seus clientes.

Nesse sentido, as organizações precisam oferecer serviços de qualidade, com processos de atendimento que garantam uma assistência eficiente e eficaz. Ao mesmo tempo, precisam manter a viabilidade financeira, garantindo sua produtividade.

Nesse contexto, as instituições precisam avaliar o nível de satisfação de seus clientes, de modo a atingir suas expectativas em relação aos serviços oferecidos. É importante ressaltar que os serviços prestados na área médica-assistencial são totalmente intangíveis, dificultando a avaliação do cliente.

Além disso, fatores como a resposta individual à doença e ao tratamento podem influenciar diretamente na percepção do cliente quanto ao serviço

prestado. Esses fatores não podem ser controlados pelos prestadores dos serviços, dificultando a previsão dos resultados.

A percepção dos clientes em relação aos serviços de saúde, geralmente, transcorre em relação a dois eixos fundamentais: o interpessoal e o técnico. O interpessoal relaciona-se com a interação psicológica social entre os profissionais que prestaram o atendimento e o cliente. O eixo técnico refere-se à utilização da ciência e tecnologia da medicina na abordagem de um problema de saúde.

A avaliação do eixo técnico parece ser realizada como maior dificuldade pelos clientes, na medida em que os mesmos, muitas vezes, não possuem conhecimento que permita uma avaliação adequada. Contudo, a avaliação interpessoal é feita sem dificuldade. Além disso, o ambiente e as instalações também são alvo de avaliação do cliente.

Ir de encontro às expectativas dos clientes é fundamental para garantir a produtividade de qualquer organização. Isso não é diferente quando se trata de assistência médica hospitalar.

Os pacientes configuram-se em um tipo diferenciado de clientela, na medida em que, na maioria das vezes, não estão procurando o serviço de assistência médica por desejo próprio, mas porque necessitam desse serviço. Essa situação pode gerar grandes expectativas por parte do cliente, aumentando o seu nível de exigência.

Durante o atendimento, diferentes fatores podem influenciar a percepção do paciente em relação ao serviço prestado. Levando-se em consideração que os bens mais valiosos de uma pessoa são sua saúde e sua vida, instala-se uma grande expectativa já na primeira consulta.

Nesse contexto, Rodrigues et al. (2011), aponta alguns fatores determinantes para que sejam atendidas as expectativas dos clientes:

Velocidade no atendimento — Os atendimentos de recepção e sala de espera devem ser realizados com cortesia e agilidade, evitando filas e atrasos desnecessários. Os profissionais de enfermagem devem possuir as competências necessárias para garantir um cuidado eficiente e eficaz, minimizando o desconforto do paciente na realização dos procedimentos.

A agilidade no atendimento médico é fundamental para a satisfação do cliente, desde que ela não prejudique a qualidade do serviço oferecido. O paciente precisa perceber que o atendimento está sendo realizado por uma pessoa que está interessada em resolver seu problema com a máxima eficácia. Para isso, o profissional deve realizar a consulta sem pressa, demonstrando atenção e interesse pelo paciente.

Tratamento humanizado — A humanização do cuidado é fundamental no tratamento do paciente. Quando o paciente procura o atendimento médico, ele está vulnerável, ansioso, nervoso, temeroso em relação ao futuro que o espera.

A atenção que recebe, quando feita de modo cortês, com o profissional demonstrando preocupação em ajudá-lo e em diminuir seu sofrimento, diminui sua angústia e aumenta a sua confiança em relação ao serviço oferecido pela equipe de saúde. Além disso, o estabelecimento de uma relação de confiança aumenta a adesão do paciente ao tratamento proposto.

Ambiente — O ambiente deve ser iluminado, ventilado e, principalmente, higienizado. É preciso que se tenha em mente que as pessoas que procuram um serviço de saúde podem estar com o sistema imunológico fragilizado, estando suscetíveis a infecções oportunistas. O ambiente deve oferecer condições para que os pacientes sejam atendidos confortavelmente e dentro dos padrões de biossegurança previstos na legislação.

Disponibilidade — A demora no atendimento é um dos principais fatores relacionados à insatisfação do cliente no atendimento. As pessoas não querem ficar horas sentadas esperando por uma consulta ou exame. A indisponibilidade dos profissionais gera irritação e insatisfação e deve ser corrigida com a organização da agenda de forma a ofertar os serviços sem que se façam longas filas de espera.

Segundo Rodrigues et al. (2011), as expectativas dos clientes em relação ao serviço passam por três níveis distintos:

1. Serviço desejado: o tipo de serviço que o cliente almeja receber, que vai de encontro com suas melhores expectativas.
2. Serviço adequado: o tipo de serviço que o cliente considera aceitável.
3. Zona de tolerância: o intervalo existente entre o que o paciente ainda reconhece e tem a tendência de aceitar e o real desempenho do serviço oferecido.

Para que se possa melhorar a gestão de qualidade dos serviços de saúde e ir de encontro às expectativas dos clientes, faz-se necessário:

- reconhecer que as pessoas têm expectativas diferentes em relação ao desempenho de cada tipo de serviço;
- saber diferenciar as expectativas gerais do paciente das expectativas em relação ao serviço que está sendo utilizado;

- observar e informar o paciente sobre os fatores controláveis e não controláveis do serviço prestado;
- concordar que diferentes pacientes podem ter expectativas semelhantes em relação aos serviços ofertados;
- planejar e implementar ações que estejam em consonância com as expectativas dos clientes.

Dessa forma, instituições de saúde devem manter constante monitoramento da qualidades de seus serviços, de modo a conquistar uma clientela que garanta a produtividade da instituição, viabilizando suas atividades. Para isso, os três níveis administração, estratégico, tático e operacional devem trabalhar articulados e em consonância com os interesses da sua clientela.



Link

A atenção básica no Brasil é descentralizada, buscando estar o mais perto possível das pessoas, constituindo-se no pilar central do sistema único de saúde. Ela é o contato inicial dos usuários, regida pelos princípios da universalidade do acesso, integralidade no cuidado, da equidade, da responsabilização, da humanização e da participação social.

A atenção básica é regulada pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), documento que formaliza seu funcionamento, apontando suas diretrizes e normas de funcionamento.

Você pode ampliar seu conhecimento acessando o documento da PNAB na íntegra, no link:

<https://goo.gl/D2Saur>



Referências

BRASIL. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 16 fev. 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Portaria nº. 2.436, de 21 de setembro de 2017*. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF, 2017. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html. Acesso em: 16 fev. 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990*. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, DF, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm. Acesso em: 16 fev. 2019.

BRASIL. *Lei nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990*. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências inter-governamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Brasília, DF, 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm. Acesso em: 16 fev. 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. *O SUS de A a Z: garantindo saúde nos municípios*. 3. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009. (Série F. Comunicação e Educação em Saúde).

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. *Política Nacional de Atenção Básica*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2019.

FIOCRUZ. *A Revolta da Vacina*. Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/revolta-da-vacina-2>. Acesso em: 16 fev. 2019.

FERREZ, M. *Santa Casa de Misericórdia*. Rio de Janeiro, 1895. Disponível em: <http://brasilianafotografica.bn.br/brasiliiana/handle/20.500.12156.1/2553>. Acesso em: 16 fev. 2019.

GIESEL, V. T.; TRENTIN, D.T. *Fundamentos de saúde para cursos técnicos*. Porto Alegre: Artmed, 2017. (Série Tekne).

HISTÓRIA DO BRASIL. *Revolta da vacina: resumo, causas*. Brasil, 2019. Disponível em: https://www.historiadobrasil.net/resumos/revolta_da_vacina.htm. Acesso em: 16 fev. 2019.

MOSSER, G.; BEGUN, J. W. *Compreendendo o trabalho em equipe na saúde*. Porto Alegre: AMGH, 2016. (Série Lange).

PAIM, J. S. Modelos de atenção e vigilância da saúde. In: ROUQUAYROL, M. Z.; ALMEIDA, F. N. (Org.). *Epidemiologia e saúde*. 6. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. p. 567-586.

RODRIGUES, M. V. et al. *Qualidade e acreditação em saúde*. Rio de Janeiro: FGV, 2011.

SEGRE, M.; FERRAZ, F. C. O conceito de saúde. *Revista Saúde Pública*, v. 31, n. 5, p. 538-542, 1997. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsp/v31n5/2334.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2019.

Leituras recomendadas

AROUCA, A. S. da S. *O dilema preventivista: contribuição para a compreensão crítica da medicina preventiva*. São Paulo: UNESP, 2004.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. *As redes de atenção à saúde*. Brasília, DF, [2019]. Disponível em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/smp_ras.php. Acesso em: 16 fev. 2019.

BRASIL. Ministério Público Federal. *Manual de atuação do Ministério Público Federal em defesa do Direito à Saúde*. Brasília, DF, 2005. Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/saude/manual_atuacao.pdf. Acesso em: 16 fev. 2019.

GONÇALVES, E. L. (Org.). *Gestão hospitalar: administrando o hospital moderno*. São Paulo: Saraiva, 2006.

KIDD, M. *A contribuição da medicina de família e comunidade para os sistemas de saúde: um guia da Organização Mundial de Médicos de Família (WONCA)*. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.

MARKLE, W.; FISHER, M. A.; SMEGO JR, R. A. *Compreendendo a saúde global*. 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015.

PELISSARE, A. S.; VANALLE, R. M. Qualidade em serviços de saúde: a percepção do cliente externo: estudo de caso de um hospital de Vitória/E.S. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS, out. 2003, Guarapari. *Anais eletrônicos [...]*. Disponível em: <https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/2536/2536>. Acesso em: 16 fev. 2019.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:

